

TEMA 3.29 • OBSTETRICIA

Síndrome de HELLP

PERFIL EUNACOM 2.01.2.023

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de HELLP

Siglas

- **H** = Hemolysis (hemólisis)
- **EL** = Elevated Liver enzymes (transaminasas elevadas)
- **LP** = Low Platelets (trombocitopenia)

Importancia

- **Riesgo materno Y fetal** (ambos pueden fallecer)
- **Interrumpir de inmediato** ante el diagnóstico
- Es una complicación de la preeclampsia severa (en la mayoría)

Clínica

TABLA 3.29.1: CARACTERÍSTICA VS DETALLE	
CARACTERÍSTICA	DETALLE
Asociación	Preeclampsia severa (HTA + proteinuria) → HELLP = PE severa automáticamente
Síntoma cardinal	Dolor epigástrico (hígado inflamado/distendido → puede romperse)
Otros	Náuseas, anorexia, astenia, ictericia
Complicación grave	Rotura hepática → hemoperitoneo
Fetal	Sufrimiento fetal agudo

Diagnóstico

TABLA 3.29.2: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
Hemograma	Anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos, equinocitos) + trombocitopenia (< 100.000)
LDH	Marcadamente elevada
Transaminasas (GOT/GPT)	Elevadas
Bilirrubina	Puede estar elevada

NOTA CLÍNICA

Diagnóstico diferencial: PTT (púrpura trombocitopénica trombótica) puede ser indistinguible, pero: - PTT raramente afecta el hígado - PTT es más frecuente en la primera mitad del embarazo o fuera del embarazo - HELLP: siempre 2ª mitad + asociado a preeclampsia

Tratamiento

- **Interrupción inmediata** (habitualmente cesárea)
- **Sulfato de magnesio** — profilaxis de eclampsia (se asume PE severa subyacente)
- Soporte: transfusión plaquetaria si < 50.000 o sangrado activo; manejo de HTA

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Síndrome de HELLP: Diagnóstico | Examen | Hallazgo | ---|---| | Hemograma | Anemia hemolítica mic... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome de HELLP. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Siglas
- Importancia
- Clínica
- Diagnóstico
- Tratamiento
- = Hemolysis (hemólisis) -
- = Elevated Liver enzymes (transaminasas elevadas) -

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE HELLP)

PREGUNTA 1

En relación a Síndrome de HELLP: Diagnóstico | Examen | Hallazgo | |---|---| | Hemograma | Anemia hemolítica mic... ¿cuál es la conducta correcta?

- A) El diagnóstico de Síndrome de HELLP se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Síndrome de HELLP debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Síndrome de HELLP requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Síndrome de HELLP es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Síndrome de HELLP no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Síndrome de HELLP?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Síndrome de HELLP. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: SÍNDROME DE HELLP

note Diagnóstico diferencial: PTT (púrpura trombocitopénica trombótica) puede ser indistinguible, pero: 1. Interrupción inmediata (habitualmente cesárea) 2. Sulfato de magnesio — profilaxis de eclampsia (se asume PE severa subyacente) 3. Soporte: transfusión plaquetaria si < 50.000 o sangrado activo; manejo de HTA